Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
2ª Vara Cível

SENTENÇA

VISTOS E EXAMINADOS estes **Autos n° 0802141-16.2018.8.12.0002** em que é Autor **RENILDO PEREIRA MENDONÇA** e é Ré **CASSEMS – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Renildo Pereira Mendonça, qualificado na petição inicial, através da Defensoria Pública Estadual, ingressou com esta *Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais* contra **Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul - CASSEMS**, também qualificada.

Pleiteia o Autor, discorrendo acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano, a título de tutela de urgência, a concessão de liminar determinando à Ré que lhe volte a disponibilizando-lhe a

Mod. 990016807 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1750, Dourados-MS - E-mail: dou-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

internação/assistência domiciliar (*home care*), com enfermagem e fisioterapia diárias, fonoaudiólogo semanal, nutricionista quinzenal, atendimento médico mensal, disponibilização de materiais fixos e ambulância para locomoção, além de tudo quanto for necessário para preservação de sua vida, dada a fragilidade de seu quadro de saúde, de acordo com orientação médica.

Aduz, em resumo, contar atualmente com 39 anos de idade e ser beneficiário do plano de saúde disponibilizado pela Ré, na condição de dependente da esposa, sua curadora provisória e representante legal, Luciene Castaldeli dos Santos (titular do plano – fls. 40/45).

Relata encontrar-se restrito ao leito por conta das sequelas neurológicas (*TCE grave - lesão axonal difusa e e encefalopatia pós anóxica e uso contínuo de fraldas*) decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 16/outubro/2017, que lhe ocasionou traumatismo cranio-encefálico grave e três paradas cardiorrespiratórias.

Conta ter sido encaminhado da cidade de Itaquiraí/MS ao Hospital da Vida de Dourados para realização de tratamento, e transferido, em 22/outubro/2017, à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Evangélico local, de onde recebeu alta para prosseguir o tratamento na enfermaria em 14/novembro/2017.

Relata, após recomendações do médico neurologista, Dr. Adolfo Teixeira, em 04/12/2017, das fisioterapeutas Vanessa Carvalho e Ronice Silva Santana, em 19/12/2017, da nutricionista Celia Mizuno Prado, em 07/12/2017 e da Enfermeira Cláudia de Jesus Santos, em 13/12/2017, e requerimento de sua curadora, em 21/dezembro/2017, a Ré autorizou ***"a implementação do serviço de internação e atendimento domiciliar a ser executada pela empresa terceirizada Vida Lar – Assistência Domiciliar em Saúde no domicílio do Autor, com: Técnico em Enfermagem 24 horas por dia, enfermeiro visitador uma vez por semana, nutricionista quinzenal, fisioterapia uma vez ao dia, fonoaudiologia duas vezes por semana, atendimento médico mensal, materiais fixos e remoção por ambulância." (sic).***

Mod. 990016807 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1750, Dourados-MS - E-mail: dou-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

Menciona, apesar da recomendação feita em 21/fevereiro/2018, pelo médico, Dr. José Alverto Salvador Lemos e outros profissionais, para que fosse prorrogado seu tratamento domiciliar com os cuidados de *enfermagem 24 horas, fisioterapia diária, fonoaudiologia 5 vezes por semana, nutricionista quinzenal e médico mensal*, a Ré comunicou a titular do plano e sua responsável, que a partir daquela data a extensão da prestação dos serviços *home care* seria reduzida da seguinte forma: *"Tec. Enfermagem 06 hrs, Fisioterapia 5x semana, Fonoterapia 2x semana, Enfermagem semanal, Médico e Nutricionista mensal"* (fls. 44).

Entende ser abusiva a redução do tratamento domiciliar (*home care*), diante da recomendação médica e dos demais profissionais que o acompanham e da gravidade de seu quadro de saúde.

Assim expondo, destacando a gravidade das sequelas que o acometem, a existência de obrigação contratual por parte da Ré, diante de um caso de urgência e/ou emergência, e discorrendo, finalmente, sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada (***verossimilhança da alegação e perigo de dano)***, destacando os riscos de uma infecção hospitalar em caso de eventual necessidade de uma internação futura, caso não sejam seguidas as recomendações médicas do tratamento *home care* como vinha sendo realizado, pleiteou a concessão da liminar e, ao final, a procedência do pedido para torna-la definitiva, com a condenação da Ré nas verbas da sucumbência. Requereu a citação da Ré, a inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Protestou genericamente por provas. Atribuiu à causa o valor de R$ 16.994,80. Juntou documentos.

Concedida a liminar em parte (fls. 115/125), contra esta decisão o Autor manejou embargos de declaração (fls. 130/134), já analisados e rejeitados (fls. 137/140).

Feita a citação (fls. 136), prejudicada tentativa de composição em audiência (fls. 148 e fls. 156/157), em seguida, a Ré fez-se representar nos autos, ofertando contestação (fls. 158/191).

Defende, inicialmente, em razão de ser uma entidade

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

fechada em regime de autogestão em saúde e sem fins lucrativos, a não incidência das regras do diploma consumerista, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado com a edição da Súmula 469.

Pugna pela improcedência da pretensão inicial, dizendo não estar obrigada ao fornecimento de tratamento domiciliar (home care), seja por ausência de previsão contratual (plano básico), seja por estar registrada na ANS apenas *"como um plano de assistência com cobertura para segmentação hospitalar e ambulatorial" (sic)*, a despeito de ter concedido, excepcionalmente, a prestação desse serviço ao Autor;

Destaca que o Autor não necessita de atendimento por "Técnicos de Enfermagem" e/ou de "enfermagem mensal" (sic), mas tão somente de tratamento multidisciplinar, como fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista e médico mensal, nos termos da contratação e do que determina a RN 428/2017;

Sustenta que os relatórios acostados aos autos apontam boa evolução do paciente, que já tolera ficar com cânula plástica ocluída de forma intermitente, tendo ocorrido melhora na disfagia;

Questiona o equilíbrio econômico financeiro para justificar manutenção dos serviços de atendimento domiciliar pretendidos pelo Autor;

Impugna o pedido de assistência gratuita, pugna pela revogação da liminar concedida initio litis, e a improcedência do pedido com a condenação do Autor nas verbas da sucumbência. Protestou genericamente por provas. Junta documentos.

Manifestando-se às fls. 270/271, o Autor juntou cópia de ofício expedido pela Ré contemplando o fornecimento de técnica de enfermagem 24 horas, fisioterapia um vez ao dia, fonoaudilogia duas vezes por semana, nutricionista semanal, acompanhamento médico mensal e enfermagem semana (fls. 272), e de relatório médico destacando a imprescindibilidade de acompanhamento psicológico (fls. 273) e, às fls. 276/277, pediu reconsideração da decisão de fls. 156-157 em razão de

Mod. 990016807 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1750, Dourados-MS - E-mail: dou-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

encontrar-se absolutamente impossibilitado de comparecer à audiência.

A Ré refuta a necessidade de atendimento psicológico ao Autor, ancorando-se no parecer do médico que o assiste, Dr. Marco Antonio Veloso, no Relatório Evolutivo do Paciente realizado pela VIDALAR, com indicação de evolução do paciente, e na liminar concedida initio litis que a não contemplou (fls. 282/283).

O Autor disse sobre a resposta, refutando todos os pontos nela suscitados e ratificando os termos de seu pedido inicial (fls. 292/308).

Especificadas as provas (fls. 311), o feito foi saneado (fls. 404/408).

Autor e Ré apresentaram documentos (fls. 423/428 e 434/441), sobre os quais foi-lhes dada oportunidade para manifestação (fls. 432/433 e 445/448), retornando, em seguida, os autos conclusos.

É o Relatório. Passo a DECIDIR.

A pretensão do Autor, com esteio nos artigos 12, inciso I, letra "b", inciso II, alíneas "c " e "e", e 35-C da Lei 9.656/98 e art. 51, §1º, inciso II, do CDC, já antecipada em parte, com o deferimento da liminar, é compelir a Ré, administradora de seu plano de saúde, a restabelecer a prestação, em sua residência, dos serviços de: a) enfermagem, durante 24 horas; b) sessões diárias de fisioterapia; c) cinco sessões semanais de fonoaudiologia; d) atendimento e avaliação nutricional a cada quinze dias; e e) atendimento médico mensal, com base em recomendação dos profissionais que o assistem.

Em sua defesa, a Ré, a despeito de, num primeiro momento defender a ausência de cobertura contratual; num segundo momento reconhece a necessidade da prestações destes serviços, tanto que os vinha prestando naquela forma e frequência recomendados, acatando as orientações médico/profissionais (ato incompatível com a alegada ausência de cobertura – preclusão lógica).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

A controvérsia da *vexatio quaestio* surgiu entre as partes quando a Ré reduziu quantitativamente as sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, as visitas nutricionais e as horas de atendimento de enfermeiro(a), com base em relatórios elaborados pela equipe multidisciplinar por ela contratada.

Antes de mais nada, consoante entendimento já externado por ocasião do saneamento do feito (fls. 404/408), não incidem, *in casu*, as regras do diploma consumerista, por se tratar de plano de saúde administrado por entidade sem fins lucrativos, em regime de autogestão, consoante julgamento do Recurso Especial nº. 1.285.485/PB, e na Súmula 608 daquela Corte:-

> *RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC.*
>
> *1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários.*
>
> *2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro.*
>
> *3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.*
>
> *4. Recurso especial não provido. (REsp 1285483/PB, Rel.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016)

Súmula nº 608: *aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.*

Nesta mesma linha, tem decidido e se pronunciado o e. TJMS:

E M E N T A – APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. CASSEMS. OPERADORA DE PLANO FECHADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TIPO AUTOGESTÃO. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. RECURSO ESPECIAL N. 1285483/PB. "HIPERPLASIA MAMÁRIA". PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMOPLASTIA. CIRURGIA REPARADORA. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. De acordo com o entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1285483/PB, "não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo". A Lei n. 9.656/98 é aplicável à hipótese dos autos, independentemente de ter havido a adequação do contrato firmado entre as partes a esta legislação, por se tratar de pacto de trato sucessivo. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol da Resolução Normativa nº 338/2013 da Agência Nacional de Saúde ANS não exime a operadora do plano de saúde de cobrir o tratamento necessitado pelo paciente quando o mesmo foi prescrito por profissional de saúde como adequado para tratar a patologia que lhe acomete, mormente em razão daquele rol

Mod. 990016807 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1750, Dourados-MS - E-mail: dou-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

ser meramente exemplificativo. A recusa indevida à cobertura médica enseja reparação a título de dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A determinação da quantia devida a título de danos morais, diante da ausência de critérios objetivos, está vinculada ao arbítrio do juiz e deve ater-se aos prejuízos morais sofridos pela vítima, obedecendo aos pressupostos essenciais para a sua fixação, nos termos já pacificados pela jurisprudência. (Ap. 0835651-62.2014.8.12.0001, Relator(a): Des. Sérgio Fernandes Martins, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, julg. 12/12/2018, pub. 13/12/2018).

Diante dessa conjuntura, recai sobre o Autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a real necessidade da continuidade e/ou restabelecimento da prestação dos serviços, em regime domiciliar, na forma e com a frequência que vinham sendo prestados, conforme recomendação daqueles profissionais médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e/ou nutricionista (fls. 54, 52, 51, 50, 49, 47, 57 e 58).

Isto porque, nenhum dos documentos trazidos pelas partes, com a inicial e contestação, foram conclusivos quanto à frequência e/ou assiduidade com que devem ser prestados os serviços/atendimentos, de acordo com o atual quadro de saúde e as necessidades do paciente.

A despeito da Ré defender a legalidade da recusa em manter o tratamento domiciliar que vinha sendo prestado, a ancora tão somente no parecer elaborado por seu assistente técnico que, após analisar os relatórios médicos da equipe multidisciplinar, entendeu se tratar, com base na tabela de avaliação de complexidade assistencial, ABEMID, de paciente com estado de saúde de média complexidade, com indicação de enfermagem 12 horas diárias, sessões de fonoaudiologia e fisioterapia três vezes por semana e re-avaliações trimestrais (fls. 441).

Na hipótese, o deslinde da lide é singelo e demanda **num primeiro momento**, que se verifique a necessidade ou não do Autor

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

receber atendimento domiciliar médico, fisioterápico, fonoaudiológico, nutricional e de enfermagem como anteriormente vinha recebendo em regime domiciliar (home care); **num segundo**, que se defina a natureza deste tipo de atendimento: se "internação domiciliar" ou a mera "assistência domiciliar"; e, **por terceiro,** que se identifique a existência ou não de responsabilidade da Ré pelo prestação dos serviços na extensão em que eles foram pleiteados.

De modo mais abrangente, a solução da lide, portanto, depende tão somente da análise da prova documental produzida pelas partes, notadamente pelos documentos colacionados às fls. 423/428 e 434/441.

Antes, porém, pertinente uma breve abordagem do significado do termo e da abrangência do tratamento em regime de internação domiciliar, para facilitar a compreensão da *vexatio quaestio*.

Numa tradução literal, "Home Care", expressão na língua inglesa, significa "cuidados no lar".[1]

No Portal *Home Care*, Edvaldo de Oliveira Leme[2] esclarece de forma didática o que vem a ser e no que consiste esse tipo de atendimento:

*"**O Home Care deve ser compreendido como uma modalidade contínua de serviços na área de saúde, cujas atividades são dedicadas aos pacientes/clientes e a seus familiares em um ambiente extra-hospitalar**. **O propósito do Home Care é promover, manter e/ou restaurar a saúde, maximizando o nível de independência do cliente/paciente, enquanto minimiza os efeitos debilitantes das várias patologias e condições que gerência**. Este tipo de serviço é direcionado não somente aos pacientes, como também, de forma diferenciada, aos seus familiares em qualquer fase de suas vidas; seja para aqueles que*

[1] *O termo Home Care é de origem inglesa. A palavra "Home" significa "lar", e a palavra "Care" traduz-se por "cuidados". Portanto, a expressão Home Care designa literalmente: cuidados no lar.http://portalhomecare.com.br/o-que-significa-o-termo-home-care/*

[2] *http://portalhomecare.com.Br/. Data de acesso em 03/agosto/2016.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

aguardam seu restabelecimento e retorno às suas atividades normais, ou para os que necessitam de gerenciamento constante de suas atividades como também, para pacientes que necessitam de acompanhamento em sua fase terminal. No gerenciamento desses serviços devem ser usados critérios técnico-científicos e as decisões devem ser baseadas no melhor nível de evidência clínica possível, para cada procedimento. Essa prática é necessária em função da complexidade do meio ambiente do paciente, dos tipos de cuidados médicos exigidos, dos recursos, das condições psico-físicas do cliente/paciente e das patologias à serem gerenciadas."

Élida Seguin[3] destaca que esse tipo de serviço além de mais humano, diminui os riscos de infecções e outras doenças contraídas no ambiente hospitalar, aumenta a chance e diminui o tempo de recuperação do paciente, pode ser, ainda, mais vantajoso ao próprio plano de saúde, sob o ponto de vista financeiro:-

*"(...)**1.11. Programas de Saúde - Home Care Medicina domiciliar, do termo inglês Home Care, cuidado no lar, designa um conjunto de procedimentos hospitalares que podem ser feitos em casa, visando uma recuperação mais rápida de pacientes crônicos dependentes, crônicos dependentes agudizados, gestantes, pós-cirúrgicos e terminais, dentro de um atendimento personalizado, com a participação da família no tratamento, humanizando-o e evitando a possibilidade de infecção hospitalar (...).** No final do século XX este programa teve um grande crescimento, passando a ser utilizado também para evitar co-patologias decorrentes de longa hospitalização e infecção hospitalar. (...) Claro que a Gestão do Plano considera o custo/benefício, mesmo assim, **nem todos os casos podem ser objeto de home care; somente aqueles com indicação médica de alta com cuidados domiciliares e onde existe na família um cuidador.** A Lei nº 9.656/98 instituiu procedimentos mínimos a serem cobertos pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde. A maioria dos planos de saúde cobre este tipo de serviço, pelas vantagens que traz para o paciente e para o Plano. Alguns benefícios terapêuticos não são atingidos em unidade hospitalar, pois o atendimento, dentro da atmosfera familiar, proporciona uma recuperação mais rápida e eficaz num espaço menos agressivo e afastado o risco de infecções hospitalares e quadros depressivos, comuns durante hospitalizações*

[3] *SÉGUIN, Elida. Plano de Saúde. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 46-48*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

prolongadas. ***Para que o Plano de Saúde admita o procedimento é necessária uma análise da viabilidade da implantação, inclusive a real necessidade de um atendimento domiciliar, a indicação pelo médico assistente, a solicitação da família e a concordância do próprio paciente.*** *Nestes casos, surgem as Fichas de Solicitação de Atendimento em Domicílio (SAD). O auditor do Plano deverá opinar para liberar o procedimento que exige várias figuras, como a do cuidador e os membros que compõem a equipe (médico, nutricionista, assistente social, enfermagem, fisioterapia, psicologia, fonoaudióloga). (...)* ***Neste programa o paciente não arca com o custo dos medicamentos e de materiais para curativo, seringas etc., que ficam por conta do Plano de Saúde, como quando ele está internado . O lixo médico produzido é recolhido pelo Programa, pelo menos uma vez por semana, não misturando o resíduo do tratamento com o doméstico.*** *O tempo de duração do home care dependerá do caso. Às vezes a avaliação é no sentido de que o paciente não necessita de acompanhamento 24 horas por dia, apenas 12, por exemplo. Se a família desejar o atendimento integral, deverá pagar a diferença".*

Letícia Rosa Santos[4] destaca e fundamenta as vantagens que o tratamento domiciliar pode trazer ao paciente, sua família e ao próprio plano de saúde:-

*"(...)****Vários estudos apontam que o cuidado domiciliar diminui o tempo médio de internação hospitalar, reduz o número de reinternações, reduz custos de atenção à saúde, aumenta a aderência ao tratamento do paciente sob assistência domiciliar. Além disso, nota-se a melhora da qualidade de vida do paciente e familiar*** *(...).* ***Portanto, tal estratégia proporciona maior conscientização ao paciente e cuidador do quadro patológico atual e,consequentemente, maior autonomia no tratamento, bem como as prioridades de cuidado ao paciente no domicílio são muito diferentes do cuidado realizado no hospital****.(...)* ***A transferência dos pacientes crônicos e convalescentes para o cuidado domiciliar libera o leito hospitalar, abrindo espaço para pacientes instáveis que precisam realmente de UTI, cirurgias, politraumatizados e outras enfermidades agudas, ampliando assim a oferta de leitos,***

[4] *SANTOS, Letícia Rosa. Princípios Éticos como Norteadores no Cuidado Domiciliar. Ciência e Saúde Coletiva. Editora Abrasco, v. 16, suplemento 1, mar. 2011, p. 857-859*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

diminuindo a média de permanência hospitalar, as reinternações e, consequentemente, os custos assistenciais. *Além disso, o paciente crônico gera menor receita em sua estada/dia para as instituições e sistemas de saúde, o que o tornaria um paciente ideal para ser indicado ao cuidado domiciliar. (...).* ***A implantação de serviços de saúde domiciliar pode ser a estratégia que possibilitará um maior aproveitamento dos leitos hospitalares,*** *oferecendo serviços de saúde ao público com maior eficiência e economia possíveis, reduzindo custos através da diminuição tanto do tempo das estadas nos hospitais quanto dos índices de internação, hospitalar. (...)* ***É importante ressaltar, no entanto, que isso não significa que a assistência domiciliária seja 'barata', mas que, comparativamente ao sistema hospitalar, seu custo é significativamente inferior.*** *(...). E, como salientado, a redução do tempo de internação e reinternações não traz somente vantagens para as instituições no que tange aos custos, mas também aos indivíduos que correm menos riscos em consequência das hospitalizações, e propicia a utilização dos leitos por um número maior de pessoas, ampliando a oferta de leitos, ou seja, agiliza a liberação de leitos da unidade hospitalar destinados a doentes passíveis de hospitalização ou a portadores de casos mais graves. Diante dos custos hospitalares elevados e do baixo benefício resultantes das internações, os cuidados secundários estão sendo deslocados para os ambulatórios e para o domicílio do cliente. Pois a manutenção do atual modelo centrado na hospitalização significará criar uma situação de superlotação das unidades hospitalares, ocupadas por doentes idosos, com doenças crônico-degenerativas, aumentando os custos da assistência à saúde e comprometendo a qualidade do atendimento (...) O atual contexto econômico e social, com um aumento crescente da demanda dos serviços de saúde, necessita de um modelo de atenção à saúde que otimize os recursos escassos.* ***Desta forma, o cuidado domiciliar surge como modelo harmônico com a economia vigente e que propicia uma adequada assistência às necessidades dos usuários*** *".*

Já a ANVISA, em sua RDC nº 11, editada em 26/janeiro/2006, adota definições e conceitos específicos para o tratamento domiciliar e que merecem ser destacados nesta decisão. Confira-se:-

3. Definições

3.1 Admissão em Atenção domiciliar: *processo que se*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

caracteriza pelas seguintes etapas:indicação, elaboração do Plano de Atenção Domiciliar e início da prestação da assistência ou internação domiciliar.

3.2 Alta da Atenção domiciliar: *ato que determina o encerramento da prestação de serviços de atenção domiciliar em função de: internação hospitalar, alcance da estabilidade clínica, cura, a pedido do paciente e/ou responsável, óbito.*

3.3 Atenção domiciliar: *termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção,tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio.*

3.4 Assistência domiciliar: *conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio.*

3.5 Cuidador: *pessoa com ou sem vínculo familiar capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana.*

3.6 Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar – EMAD: *profissionais que compõem a equipe técnica da atenção domiciliar, com a função de prestar assistência clínico-terapêutica e psicossocial ao paciente em seu domicílio.*

3.7 Internação Domiciliar: *conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada.*

3.8 Plano de Atenção Domiciliar – PAD: *documento que contempla um conjunto de medidas que orienta a atuação de todos os profissionais envolvidos de maneira direta e ou indireta na assistência a cada paciente em seu domicílio desde sua admissão até a alta.*

3.9 Serviço de Atenção Domiciliar – SAD: *instituição pública ou privada responsável pelo gerenciamento e operacionalização de assistência e/ou internação domiciliar.*

3.10 Tempo de Permanência: *período compreendido entre a data de admissão e a data de alta ou óbito do paciente.*

É importante destacar que no regime do SUS – Sistema Único de Saúde, **a atenção domiciliar** está disciplinada no artigo 19,

Mod. 990016807 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1750, Dourados-MS - E-mail: dou-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

inciso "I", da Lei nº 8.080/1990[5] e pela Portaria nº 2.527, de 27 de outubro de 2011 do Ministério da Saúde:

Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.

§ 1º ***Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.***

§ 2º O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.

§ 3º O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.

Portaria 2.527/2011:-

Art. 1º Esta Portaria redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo as normas para cadastro dos Serviços de Atenção Domiciliar (SAD), a habilitação dos estabelecimentos de saúde no qual estarão alocados e os valores do incentivo para o seu funcionamento.

Art. 2º Para efeitos desta Portaria considera-se:

*I -**Serviço de Atenção Domiciliar (SAD):** serviço substitutivo ou complementar à internação hospitalar ou ao atendimento ambulatorial, responsável pelo gerenciamento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP);*

*II - **Atenção Domiciliar**: nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de*

5- *Lei 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.*

Mod. 990016807 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1750, Dourados-MS - E-mail: dou-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde; e

*III - **Cuidador**: pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o usuário em suas necessidades e atividades da vida cotidiana.*

*Art. 3º **A Atenção Domiciliar tem como objetivo a reorganização do processo de trabalho das equipes que prestam cuidado domiciliar na atenção básica, ambulatorial e hospitalar, com vistas à redução da demanda por atendimento hospitalar e/ou redução do período de permanência de usuários internados, a humanização da atenção, a desinstitucionalização e a ampliação da autonomia dos usuários.***

Art. 4º A Atenção Domiciliar é um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências e deverá ser estruturada de forma articulada e integrada aos outros componentes e à Rede de Atenção à Saúde, a partir dos Planos de Ação, conforme estabelecido na Portaria Nº 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011.

Art. 26. Para que o usuário seja incluído para cuidados na modalidade AD3, é necessário que se verifique:

I - existência de pelo menos uma das situações admitidas como critério de inclusão para cuidados na modalidade AD2; e

II - necessidade do uso de, no mínimo, um dos seguintes equipamentos/procedimentos:

a) Suporte Ventilatório não invasivo:

i. Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP); e

ii. Pressão Aérea Positiva por dois Níveis (BIPAP);

b) diálise peritoneal; e

c) paracentese.

Art. 27. Na modalidade AD3 será garantido transporte sanitário e retaguarda para as unidades assistenciais de funcionamento 24 horas, definidas previamente como referência para o usuário, nos casos de intercorrências.

Mod. 990016807 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1750, Dourados-MS - E-mail: dou-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

Art. 29. O descumprimento dos acordos assistenciais entre a equipe multiprofissional avaliadora e o usuário e familiares ou cuidadores poderá acarretar na exclusão do usuário do SAD, com garantia de continuidade do atendimento ao usuário em outro serviço adequado ao seu caso.

Art. 30. Para admissão de usuários nas modalidades AD2 e AD3 ***é indispensável à presença de um cuidador identificado.***

Art. 31. As modalidades de AD2 e AD3 contarão com infraestrutura especificamente destinada para o seu funcionamento, que contemple:

I - equipamentos,
II - material permanente e de consumo;
III - aparelho telefônico; e
IV - veículo(s) para garantia da locomoção das equipes.

A assistência e a internação domiciliares também são regulamentadas pelas Resoluções nº 270/2002 e nº 464/2014 do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e Resolução nº 1.668/2003 do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Em relação aos planos e seguros privados de assistência médica à saúde, a Lei nº 9.656/98 não incluiu o tratamento médico em domicílio (*home care*) dentre os procedimentos mínimos e/ou obrigatórios que devem ser oferecidos/cobertos pelas operadoras de planos de saúde, mas também não o excluiu.

A ANS – Agência Nacional de Saúde, através de sua Resolução Normativa nº 338/2013, cuidou de preencher essa lacuna, estabelecendo os seguintes parâmetros:-

Art. 3º A atenção à saúde na saúde suplementar deverá observar os seguintes princípios:

(...)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

II - integralidade das ações respeitando a segmentação contratada;

III - incorporação de ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, bem como de estímulo ao parto normal;

(...)

Parágrafo único. Os princípios estabelecidos neste artigo devem ser observados em todos os níveis de complexidade da atenção, respeitando-se as segmentações contratadas, visando à promoção da saúde, à prevenção de riscos e doenças, ao diagnóstico, ao tratamento, à recuperação e à reabilitação.

Art. 13. ***Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA*** *e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do artigo 12 da Lei nº 9.656, de 1998. (Redação do caput dada pela Resolução Normativa DC/ANS Nº 349 DE 09/05/2014).*

Parágrafo único. ***Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.***

Com efeito, a cobertura e/ou prestação do serviço de *home care* dependeria de previsão contratual específica, o que, evidentemente, a inviabilizaria, já que dificilmente as operadoras de plano de saúde a disponibilizariam por livre e espontânea iniciativa nos contratos de adesão, nos quais as cláusulas são por elas estipuladas unilateralmente.

Acontece, porém, que a própria Lei nº 9.656/98, independentemente de previsão contratual entre as partes, assegura cobertura para os casos de **urgência ou emergência,** após vinte e quatro horas da contratação.

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as

Mod. 990016807 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1750, Dourados-MS - E-mail: dou-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(....)

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, *como tal definidos* ***os que implicarem risco imediato de vida*** *ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)*

Por conseguinte, uma vez constatada a necessidade de adoção do tratamento *home care*, em regime de urgência e/ou emergência, com o intento de preservar a vida, a saúde e a dignidade do paciente, eventual recusa da operadora à cobertura e/ou a extensão da prestação desse tipo de serviço, se mostra abusiva e ilegal, eis que afronta não só a própria Lei nº 9.656/98 (artigos 12, V e 35-C), como os artigos 47[6] e 51, inciso IV, do CDC[7], e os artigos 1º, inciso III[8], e 5º[9], da Lei Maior, sem olvidar do entendimento jurisprudencial já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as operadoras de planos de saúde podem alencar as doenças coberturas pelo plano, mas não o tipo de tratamento a ser indicado pelo médico na busca da preservação da vida e recuperação da saúde do paciente.

---

[6] *Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.*

[7] Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

[8] *Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:*

(....)

III - a dignidade da pessoa humana;

[9] *Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do* ***direito à vida,*** *à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

(....) ***O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor*** *(REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). Aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 869843 / CE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0044730-1 Relator(a) Ministro MOURA RIBEIRO (1156) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 21/06/2016 Data da Publicação/Fonte DJe 30/06/2016)*

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ***PLANO DE SAÚDE. "HOME CARE". RESIDÊNCIA. INSTITUTO DE IDOSOS. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.*** *INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.1.* ***O acórdão recorrido assentou que o serviço "home care" para o quadro clínico do agravado é de suma importância, pois é o único meio que o paciente possui para uma sobrevida com mais qualidade, uma vez que há nos autos recomendação médica para a referida modalidade de tratamento subscrita por relatório médico demonstrando a real necessidade de tratamento. (....)*** *. (AgInt no AREsp 873948 / DF AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0052657-0 Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 17/05/2016 Data da Publicação/Fonte DJe 02/06/2016)*

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ***PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE**. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO VALOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (....)* ***Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura*. (....)(AgRg no AREsp 725203 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0137389-7 Relator(a) Ministro MOURA RIBEIRO (1156) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 15/09/2015 Data da Publicação/Fonte DJe 24/09/2015)*

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. 1 - Polêmica em torna da cobertura por plano de saúde do serviço de "home care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3- Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor . Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 4- ***Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital****. 5 - Dano moral reconhecido pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ. 6 - RECURSO*

Mod. 990016807 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1750, Dourados-MS - E-mail: dou-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(REsp 1378707 / RJ RECURSO ESPECIAL 2013/0099511-2 Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) Órgão Julgador T3 – TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 26/05/2015 Data da Publicação/Fonte DJe 15/06/2015 RSTJ vol. 240 p. 377)

(....)3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, ***sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.*** *4. Agravo regimental não provido.* ***(AgRg no Ag 1.325.939/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 09/05/2014)***

Contudo, na ausência de previsão contratual, como ordinariamente acontece, a adoção e/ou utilização do serviço de internação domiciliar (*home care*) não deve ser feita aleatoriamente, ao contrário, deve seguir alguns parâmetros.

Valho-me, então, dos critérios definidos pela Terceira Turma do STJ, no julgamento realizado em 18/08/2015, do REsp 1537301/ RJ, através do voto prevalecente do Ministro Ricardo Villas Bôas Vueva:-

(....)Na ausência de regras contratuais que disciplinem a utilização do serviço, a internação domiciliar pode ser obtida como conversão da internação hospitalar. Assim, para tanto, há a necessidade ***(i) de haver condições estruturais da residência, (ii) de real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) da indicação do médico assistente, (iv) da solicitação da família, (v) da concordância do paciente e (vi) da não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. (...)*** *(REsp*

Mod. 990016807 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1750, Dourados-MS - E-mail: dou-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

1537301 / RJ RECURSO ESPECIAL 2015/0048901-2 Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 18/08/2015 Data da Publicação/Fonte DJe 23/10/2015)

Pois bem. O Autor, na data da propositura da ação, apresentava diagnóstico de sequelas neurológicas (TCE grave – lesão axonal difusa e encefalopatia pós anóxica), com dificuldade para deglutição, fala e movimento corporal, totalmente dependente de terceiros e encontrava-se "acamado e afásico" (sic), sendo-lhe recomendado, pelo médico que o assiste, Dr. José Alberto Salvador Lemos, *"acompanhamento de **enfermagem 24 horas, fisioterapia diária, fonoaudiólogo cinco vezes por semana, nutricionista quinzenal** e médico quinzenal"* para prorrogação e/ou continuidade do tratamento domiciliar que vinha sendo feito (fls. 50/51), relato este que atrelado àqueles feitos pelos profissionais de fonoaudiologia e fisioterapia (fls. 423 e 425) e, ainda, pelos médicos Fábio Riuto (fls. 426), Gecimar Teixeira (fls. 424) e Paula Santos de Souza (fls. 427/428), evidenciam, de forma irrefutável, a extrema gravidade do quadro clínico do beneficiário e a necessidade de cuidados daqueles cuidados que vinham sendo prestados, apenas com a ressalva de atendimento médico mensal e não quinzenal como sugerido às fls. 51, em domicílio para manutenção da vida e preservação de sua dignidade.

Desnecessária a realização de prova técnica, *in casu*, não só por não terem as partes por ela protestado, de forma justificada no tempo e modo oportunos, mas porque as colacionadas aos autos pela Autora (fls. 423/428), não foram infirmadas, de forma específica e/ou a contento, pela Ré.

Observe-se, mero questionamento quanto ao grau de complexidade (baixa, média ou alta), não justifica a recusa para o atendimento da extensão do tratamento, em regime de internação domiciliar, de acordo com as recomendações dos profissionais que assistiram e/ou avaliaram o paciente.

A recomendação pela manutenção do suporte de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

enfermagem diária por 24 horas não só se justifica pelo risco de *"broncoaspiração e readmissões hospitalares" (sic* -fls. 426), como também como forma de redução e prevenção de agravos (fls. 427/428).

A conjuntura fático probatória, portanto, evidencia que o Autor, atualmente com 40 anos de idade (fls. 38), está acometido por graves patologias que comprometem sua autonomia para realização de suas atividades básicas como vestir-se, alimentar-se e cuidar da própria higiene pessoal e, ainda, de expressar-se, necessitando de tratamento em seu domicílio, recomendados pelo médico que lhe assiste e vários outros profissionais que o acompanharam e/ou avaliaram, como única forma de se evitar o agravamento de seu quadro clínico.

Fica claro, portanto, que não se trata de assistência domiciliar ambulatorial, mas sim de uma típica **"internação domiciliar"**, já que o quadro de saúde do Autora, além de crônico, é grave, demandando cuidados especiais, em tempo integral e serviços de enfermagem e acompanhamento médico e por outros profissionais da forma como vinham sendo realizados.

Se tanto não bastasse, esta modalidade de atendimento foi expressamente indicada e justificada pelo médico assistente.

A Ré, por sua vez, não se desvencilhou do ônus de demonstrar que o atendimento domiciliar pretendido pelo Autor tenha o condão e/ou o potencial de afetar o equilíbrio contratual de forma a comprometer e/ou inviabilizar o tratamento.

Verificando-se, portanto, à saciedade que o Autor encontra-se preso ao leito e totalmente dependente de terceiros para realização de atividades básicas à sua sobrevivência, e a prévia recomendação médica para que seu tratamento seja realizado em regime de continuidade e *in* domicílio, tal qual vinham sendo adotados antes de serem reduzidos por determinação da Ré (*enfermagem 24 horas, fisioterapia diária, fonoaudiólogo cinco vezes por semana, nutricionista quinzenal e médico mensal)***,** sua sua pretensão deve ser acolhida.

Mod. 990016807 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1750, Dourados-MS - E-mail: dou-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada. Agravado com histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica, possível insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral isquêmico (AVC). ***Tratamento Domiciliar. "Home care"****.* ***Indicação de assistência de enfermagem nas 24 horas e fisioterapias diárias, por médico particular. Relatórios divergentes. Comprovação técnica por profissional idôneo da necessidade e utilidade do tratamento pretendido. Presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada.*** *Agravo a que se nega provimento". (TJ-SP - AI: 01147298820138260000 SP 0114729-88.2013.8.26.0000, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 25/07/2013, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2013) (sem grifo ou destaque no original).*

"Agravo de instrumento. Seguros. ***Plano de saúde. Serviço de home care. Autora portadora de demência e acometida por vários acidentes vasculares cerebrais. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência da Súmula 469 do STJ. Havendo prova da indicação médica de atendimento domiciliar, com prescrição de cuidados e procedimentos imprescindíveis à manutenção da estabilidade do quadro clínico da agravada e que pressupõem conhecimento técnico, mostram-se preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela.*** *Provimento que contempla o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à vida e à saúde. Agravo de instrumento provido". (Agravo de Instrumento Nº 70059961706, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 29/05/2014)*

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA – NÃO COBERTURA – TRATAMENTO

Mod. 990016807 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1750, Dourados-MS - E-mail: dou-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DA DOENÇA – CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS TERMOS DO ARTIGO 51, IV, DO CDC *– RECURSO IMPROVIDO.A Legislação Consumerista, em seu artigo 51, inciso IV, classifica como nulas de pleno direito as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabelecem obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé e equidade. São abusivas as cláusulas contratuais do plano de saúde que vedam a cobertura pretendida, considerada indispensável ao tratamento da doença, ou a flexibilização dos prazos de carência. Recurso improvido." (TJMS; Agravo Regimental em Apelação Cível - Ordinário - N. 2007.009658-3/0001-00 - Campo Grande; Primeira Turma; Relator Desembargador Divoncir Schreiner Maran; julgado em 24.3.2009).*

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C COBRANÇA – PLANO DE SAÚDE – NÃO-COBERTURA DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA – PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DA AUTORA-APELADA – CLÁUSULA ABUSIVA NOS TERMOS DO ARTIGO 51, IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA MANTIDA *– RECURSO NÃO PROVIDO.Ainda que o contrato de plano de saúde tenha sido firmado anteriormente à edição da Lei n. 9.656/98, isso não impede a sua análise em consonância com as diretrizes do CDC. As cláusulas contratuais do plano de saúde que excluem ou limitam sessões de quimioterapia, sendo tais procedimentos indispensáveis ao tratamento de doença acometida pela segurada, são abusivas." (TJMS; Apelação Cível - Ordinário - N. 2006.014654-8/0000-00 - Campo Grande; Primeira Turma Cível; Relator Desembargador João Maria Lós; julgado em 27.5.2008).*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC RESTITUIÇÃO DE VALORES – AGRAVO RETIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA DOPPLER E IMPLANTAÇÃO DE FILTRO NA VEIA CAVA SUPERIOR DA PACIENTE – PROCEDIMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA CONSTATADA NA GENITORA DA APELADA – CLÁUSULA CONTRATUAL DE NÃO COBERTURA DE "RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" QUE DEVE SER QUALIFICADA COMO ABUSIVA NOS TERMOS DO ARTIGO 51, IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS CORRETAMENTE RECONHECIDO NA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO*.A operadora de serviços de assistência à saúde que presta serviços remunerados àqueles que aderiram ao seu plano tem sua atividade regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pouco importando o nome ou a natureza jurídica que adota.Tendo a lide sido solucionada com fundamento no código consumerista, pouco importa ter sido o contrato de plano de saúde firmado anteriormente à edição da Lei n. 9.656/98.São abusivas as cláusulas contratuais do plano de saúde que excluem de sua cobertura os gastos dispendidos em procedimentos indispensáveis ao tratamento de doença acometida pela segurada." (TJMS; Apelação Cível - Ordinário - N. 2009.005042-8/0000-00 - Campo Grande; Quinta Turma Cível; Relator Desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva; julgado em 25.2.2010).*

Como destacado alhures ao longo desta decisão, o serviço "home care" (tratamento domiciliar), é tão somente um desdobramento ou a continuidade, e não uma conversão do tratamento hospitalar contratualmente coberto, de maneira que sua prestação não pode ser limitada pela operadora do plano de saúde, à qual não é dado interferir na

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

linha e/ou na forma e/ou extensão de tratamento escolhida pelo profissional médico para preservação da saúde e a vida do paciente.

No caso em comento, a despeito da ausência do instrumento contratual celebrado entre as partes, não há controvérsia que qualquer contratação dessa natureza assegura cobertura para o atendimento de todas as especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, todos os tratamentos constantes no Rol de Procedimentos Médicos definidos pelo Ministério da Saúde, e os casos de urgências e emergências; a redução quantitativa do tratamento determinada pela Ré, portanto, foi despropositada e abusiva, diante da recomendação e solicitação feitas por médicos especialistas, conclusão esta corroborada por outros elementos de prova nos autos.

Ora, se o plano de saúde contratado pelo Autor prevê cobertura para doenças neurológicas em geral, fato incontroverso, é manifesta e evidente a abusividade e a nulidade de qualquer disposição contratual que exclua da cobertura contratual o tratamento que, por recomendação médica e pelas particularidades do paciente, deva ser prestado em domicílio e não em ambiente hospitalar, na medida em que inviabiliza a própria finalidade do negócio jurídico que vincula as partes.

A exclusão deste serviço e/ou a sua limitação ao critério exclusivo da operadora do plano, configura, no caso, um abuso da posição contratual preponderante, vez que a usuária, por expressa, reiterada e fundamentada recomendação e solicitação médica, necessita receber no âmbito domiciliar o mesmo tratamento que seria prestado e custeado no ambiente hospitalar.

> *TAMG-028892 CONTRATO DE SEGURO SAÚDE - UNIMED BH - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PELO PLANO - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - PERÍODO DE CARÊNCIA - APLICABILIDADE DAS NORMAS INSERIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

DEFERIMENTO DO PEDIDO CAUTELAR - RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO DA DEMANDA E RECEIO DE INEFICÁCIA DO PROVIMENTO FINAL - OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 461 § 3º DO CPC E 84 § 3º DO CDC. Os contratos de seguro-saúde possuem características e sobretudo uma finalidade: o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a saúde do consumidor e de sua família ou dependentes. A efetiva cobertura (reembolso, no caso dos seguros de reembolso) dos riscos futuros à sua saúde e de seus dependentes, a adequada prestação direta ou indireta dos serviços de assistência médica (no caso dos seguros de pré-pagamento ou de planos de saúde semelhantes) é o que objetivam os consumidores que contratam com estas empresas. Não deve o fornecedor, tratando-se de procedimento de urgência e emergência, ficar discutindo a interpretação de cláusulas contratuais referentes ao período de carência que, diga-se de passagem, nos termos do artigo 12 inciso V letra "c" da Lei nº 9.656/98, deverá ter o "prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência". Ao contrário, deve sim, concentrar-se nos deveres de cuidado e cooperação oriundos do princípio da boa-fé objetiva, eis que o tratamento de saúde deve ser prestado ao consumidor com lealdade pelo seu parceiro contratual, razão pela qual, em face da relevância do fundamento da demanda, revelam-se preenchidos os requisitos inseridos nos artigos 84 § 3º do Código de Defesa do Consumidor e 461 § 3º do CPC, autorizando, pois, a concessão da tutela de urgência, visando compelir a seguradora a prestar cobertura à intervenção cirúrgica, sob pena de justificado receio de ineficácia do provimento final. (Apelação nº 0370426-1, 7ª Câmara Cível do TAMG, Rel. Unias Silva. j. 17.10.2002, unânime).

Não se pode olvidar, ainda, ter o Conselho Federal de Medicina, feito constar do artigo 1º, da Resolução 1.401, de 11/11/1993 que:-

Mod. 990016807 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1750, Dourados-MS - E-mail: dou-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

*Art. 1º - As empresas de seguro-saúde, empresas de Medicina de Grupo, cooperativas de trabalho médico, ou outras, que atuem sob a forma de prestação direta ou intermediação dos serviços médicos-hospitalares, estão obrigadas a garantir o atendimento a todas as enfermidades relacionadas no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde**, não podendo impor restrições quantitativas ou de qualquer natureza.** **(grifei e destaquei)***

Enfatize-se, por mais uma vez, o artigo 13-C da Lei 9.656/98, com a redação recebida pela Lei 11.935/09, obriga as operadoras e administradoras dos planos de saúde à cobertura do atendimento nos casos de emergência e/ou urgência, que à evidência, é a hipótese versanda.

Esta disposição normativa, porque fulcrada em princípios constitucionais de maior relevo, como da Proteção do Direito à Vida, à Saúde e à Preservação da Dignidade da Pessoa Humana, erigidos a dogmas constitucionais, sobrepuja qualquer restrição contratual em sentido contrário.

> *APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – UNIMED – CONTRATO – ÁREA REGIONAL DE ABRANGÊNCIA – CÂNCER – TRATAMENTO POR MEIO DE RADIOTERAPIA REALIZADA FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA-EMERGÊNCIA – POSSIBILIDADE – ART. 35-C DA LEI 9.656/98 – OBRIGATORIEDADE DO PLANO DE SAÚDE EM COBRIR AS DESPESAS – NÃO OCORRÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – RECURSO IMPROVIDO.* ***Em procedimentos de urgência ou emergência a prestadora de serviço de saúde é obrigada a cobrir as despesas do tratamento indicado, considerando o risco de vida da paciente, ainda que fora da abrangência da cobertura regional****. (TJMS - 1ª Turma Cível. Apelação Cível. - Ordinário - N. 2010.028993-7/0000-00 - Relator - Exmo. Sr. Des. João Maria Lós Campo Grande. Julgamento em 30.3.2011)*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
2ª Vara Cível

De forma concludente, desde que evidenciada uma situação de urgência e/ou emergência, a exigir a prestação de um atendimento célere e personalizado, como no caso invectivado, conforme recomendação médica, o plano de saúde está obrigado a prestar a cobertura imediata, sobretudo neste caso específico, em que a redução quantitativa do tratamento não está, ao menos, fundamentada na ausência dos requisitos mínimos necessários para a sua concessão, já destacados nesta decisão, quais sejam:- *(i) de haver condições estruturais da residência, (ii) de real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) da indicação do médico assistente, (iv) da solicitação da família, (v) da concordância do paciente e (vi) da não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. (...)*[10]

ISSO POSTO, com base nos artigos 487, inciso I e 497 do Código de Processo Civil; artigos 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, da Lei 9.656/98, e artigos 1º, inciso III, e 5º, da Constituição Federal, julgo procedente o pedido inicial, para:

i) tornar definitiva a liminar concedida *initio litis* (fls. 115/125) com a ampliação de sua abrangência, condenando a Ré **CASSEMS – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,** a disponibilizar/arcar e custear *a internação/assistência domiciliar (home care), incluindo serviços de enfermagem 24 horas, fisioterapia diária, nutrição quinzenal, fonoaudiologia cinco(5) vezes por semana e médico mensal,* além de tudo quanto for necessário para preservação de sua vida, em conformidade com as recomendações do(s) médico(s) que conduzem o tratamento médico do Autor, ou pelo tempo que se fizer necessário, em caráter contínuo e ininterrupto até o final do tratamento, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (art. 497, CPC), fixada provisoriamente por 30 dias;

[10] *REsp 1537301 / RJ RECURSO ESPECIAL 2015/0048901-2 Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 18/08/2015 Data da Publicação/Fonte DJe 23/10/2015*

Mod. 990016807 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1750, Dourados-MS - E-mail: dou-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
2ª Vara Cível

ii) condenar a Ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), o que faço atenta à simplicidade da causa, tempo e atenção exigidos do profissional para seu patrocínio (cf. artigo 85, §§2º e 8º, CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas e anotações necessárias.

Dourados/MS, 30 de maio de 2019.

Larissa Ditzel Cordeiro Amaral
Juíza de Direito

Mod. 990016807 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1750, Dourados-MS - E-mail: dou-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 30/05/2019 às 14:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802141-16.2018.8.12.0002 e código VSJpwxjt.